

ESCORE PRISM (PEDIATRIC RISK OF MORTALITY)

Predição de Mortalidade Pediátrica e Gravidade Fisiológica em Cuidados Intensivos

1. IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE

Nome:		Idade:	
Prontuário:		Leito:	
Setor:		Data/Hora:	___/___/___ às __:__

2. PARÂMETROS CLÍNICOS E LABORATORIAIS PEDIÁTRICOS (PRISM III)

1. Pressão Sistólica (PAS):

☐ Normal p/ idade (0) • ☐ Hipotensão moderada (3) • ☐ Hipotensão grave (7)

2. Frequência Cardíaca (FC):

☐ Normal p/ idade (0) • ☐ Taquicardia moderada (3) • ☐ Taquicardia grave / Bradicardia (4)

3. Temperatura Central:

☐ 36,0 - 38,4°C (0) • ☐ > 40°C ou < 33°C (3)

4. Reação Pupilar:

☐ Ambas reativas (0) • ☐ Uma fixa (4) • ☐ Ambas fixas/midriáticas (10)

5. Escala de Glasgow (ECG):

☐ ECG ≥ 8 (0) • ☐ ECG < 8 (6)

6. Acidose / pH Arterial:

☐ pH 7,28 - 7,48 (0) • ☐ pH 7,00 - 7,27 (2) • ☐ pH < 7,00 (6)7. Oxigenação (PaO₂ / PaCO₂):☐ PaO₂ >50 / PaCO₂ ≤50 (0) • ☐ Alterado moderado (2) • ☐ PaO₂ <40 ou PaCO₂ >65 (6)

8. Coagulação (TP / TTPa):

☐ RNI normal (0) • ☐ RNI 1,5 - 2,0 (2) • ☐ RNI > 2,0 ou TTPa alargado (4)9. Potássio Sérico (K⁺):☐ 3,0 - 5,5 mEq/L (0) • ☐ < 3,0 ou > 5,5 mEq/L (3)

10. Glicemia / Creatinina:

☐ Normais (0) • ☐ Glicemia > 200 mg/dL ou Creatinina >2x limite (2)

ESCORE TOTAL PRISM: [] PONTOS

3. ESTRATIFICAÇÃO DO RISCO DE MORTALIDADE NA UTI PEDIÁTRICA

< 10 PONTOS

Baixo Risco (< 5% mortalidade):
Resposta satisfatória à terapêutica intensiva inicial.

10 a 19 PONTOS

Risco Moderado a Alto (10% a 30%):
Disfunções orgânicas em progressão; suporte avançado.

≥ 20 PONTOS

Risco Muito Alto (> 50% de mortalidade): Falência de múltiplos órgãos; suporte invasivo pleno.

Carimbo e Assinatura do Profissional Responsável

Local e Data